

# Dłuższe engaging — *bez righting reflex*

MI dla AN: 4 procesy + 5 technik OARS+I. Adaptacje: dłuższe engaging, walidacja funkcji AN, cierpliwość. Nie klasyczne MI dla uzależnień.

**CZAS:** rama ogólna terapii, od pierwszej sesji

**REALIZACJA:** przy wysokim oporze, niskim wglądzie, ryzyku porzucenia terapii

**ŹRÓDŁO:** Miller & Rollnick (2013, *Motivational Interviewing*, wyd. 3); Waller (2012); Geller (2002, MI in ED); Treasure & Schmidt (MANTRA)

## JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **cztery procesy MI**: engaging, focusing, evoking, planning. W sekcji 02 — **pięć technik OARS+I**: otwarte pytania, afirmacje, odbicia, podsumowania, informowanie. Sekcja 03 — **siedem adaptacji MI** dla AN.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 2013) — podejście pracy z ambiwalencją oparte na *partnerstwie, akceptacji, współczuciu i wywoływaniu*. Cztery procesy: *engaging* (przymierze), *focusing* (cel zmiany), *evoking* (wywołanie *change talk*), *planning* (plan działania). **Adaptacja dla AN**: dłuższe *engaging* (ego-syntonia wymaga czasu), ostrożne *focusing* (nie narzucamy „wyzdrowienia”), eksploracja funkcji AN. *Bez MI*: konfrontacja → reactance → wzmocnienie oporu.

## 01 Cztery procesy MI — sekwencja niemechaniczna

### 1 · ENGAGING — RELACJA

**Budowanie zaufania.** Pacjent czuje się słyszany, nie oceniany. W AN *dłuższe* niż w uzależnieniach: 4–8 sesji zamiast 1–2.

### 2 · FOCUSING — CEL

**Ustalenie kierunku.** Cel pacjenta, nie terapeuty. „Co *chciał(a)byś osiągnąć?*” — może być inny niż „pełne zdrowienie”.

### 3 · EVOKING — CHANGE TALK

**Wywoływanie**, nie *narzucanie*. Pacjent sam artykułuje argumenty za zmianą. Pojawia się *później* niż w uzależnieniach.

### 4 · PLANNING — KROKI

**Konkretne kroki.** Nie wcześniej niż pacjent jest gotów. Plan przygotowany razem, nie wręczany.

## 02 Pięć technik OARS+I — operacyjne narzędzia MI

| TECHNIKA                           | CO TO ZNACZY                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>O · Otwarte pytania</i>         | Zamiast „Czy jedzenie cię martwi?” (zamknięte) — „Opowiedz, jak wygląda twoja relacja z jedzeniem”. Generuje bogatsze dane.                                                                       |
| <i>A · Afirmacje siły</i>          | Uznanie siły, którą pacjent włożył — nawet w utrzymanie AN. „Widzę, ile energii w to wkładasz” — bez ironii.                                                                                      |
| <i>R · Odbicia (najważniejsza)</i> | <i>Proste</i> — powtórz kluczowe słowa („Mówisz, że czujesz się bezpieczna, gdy nie jesz”).<br><i>Złożone</i> — dodaj hipotezę („Brzmi, jakby AN dawała ci kontrolę, której gdzie indziej brak”). |
| <i>S · Podsumowania</i>            | Co kilka minut — zbieranie wątków. „Zauważam, że mówisz <i>i</i> o trudnościach <i>i</i> o tym, co AN ci daje. Oba są prawdziwe”.                                                                 |
| <i>I · Informowanie (za zgodą)</i> | „Chcę ci coś powiedzieć o refeedingu — czy mogę?” — informowanie tylko za zgodą. Bez zgody = perswazja.                                                                                           |

## 03 Siedem adaptacji MI dla AN

### ADAPTACJA 1 — DŁUŻSZY ENGAGING

4–8 sesji budowania relacji zamiast 1–2 (jak w uzależnieniach).  
AN nie jest „motywowana do leczenia” w wyobraźni pacjenta na początku

### ADAPTACJA 2 — WALIDACJA FUNKCJI AN

Obowiazkowa. Pytaj „co AN ci daje?” z autentyczną ciekawością, bez ironii. Bez tego pacjent musi bronić AN

### ADAPTACJA 3 — CHANGE TALK PÓŹNIEJ

6–12 sesji zamiast 3–4. Nie forsuj. Wymuszone deklaracje są kruche

### ADAPTACJA 4 — MI NIE ZASTĄPI REFEEDINGU

Przy zagrożeniu życia (RED MEED) bezpieczeństwo ma pierwszeństwo. MI towarzyszy interwencji medycznej, nie zastępuje jej

**Klucz:** MI dla AN to *rama ogólna* terapii, nie osobna technika. Stosowane od pierwszej sesji do ostatniej. Najczęstszy błąd klinicystów: *righting reflex* — pokusa, by „przekonać” pacjenta („spójrz, jakie to szkodliwe”). Wywołuje *reactance*: pacjent *broni* AN. Skuteczne podejście: *wywoływanie* argumentów od pacjenta (*change talk*) zamiast ich narzucania. Pacjent jest *ekspertem* w temacie własnej AN — terapeuta jest *partnerem* w eksploracji. Ambiwalencja nie jest „*problemem*” — jest *materiałem pracy*. „Celebrate, don't fix” — Miller & Rollnick (2013). W AN *change talk* pojawia się *później* niż w uzależnieniach — średnio po 6–12 sesjach. Cierpliwość klinicysty jest warunkiem skuteczności.

⚠ MI nie zastępuje refeedingu ani interwencji medycznej. Przy zagrożeniu życia (RED MEED — BMI < 13, bradykardia, hipokaliemia) bezpieczeństwo pacjenta ma pierwszeństwo nad „czekaniem na motywację”. MI towarzyszy interwencji, nie zastępuje. Klinicysta, który czeka na „pełną motywację” pacjenta przed wprowadzeniem refeedingu, naraża jego życie.